6-4

成長期の体と痛み

痛みは体からの連絡



こんなこと、ない？

身長が伸び始めてから、

膝の下が痛い。

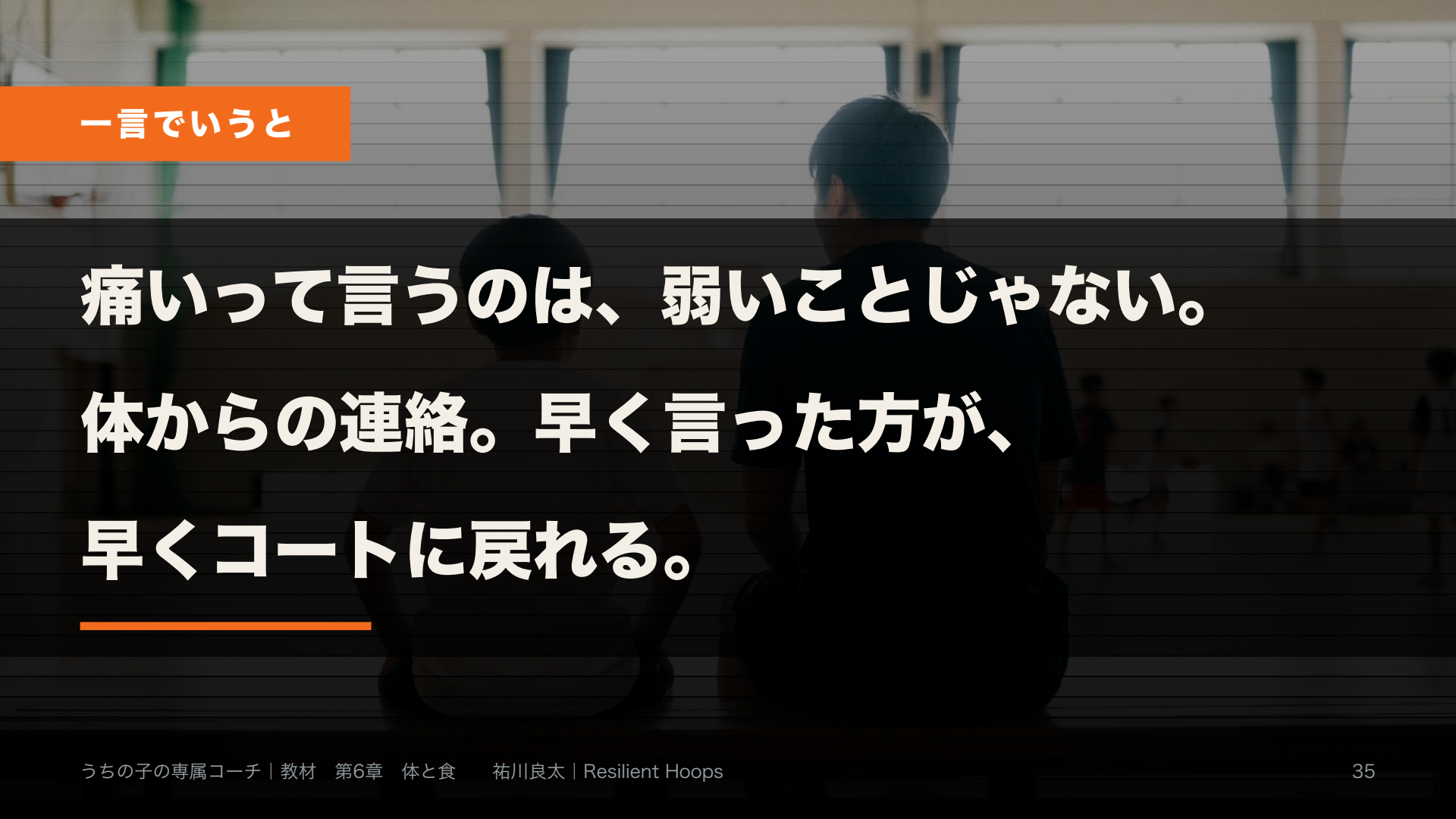
「成長痛だから大丈夫」

と言われた。

でも正座ができなくて、

階段で顔をしかめる。





一言でいうと

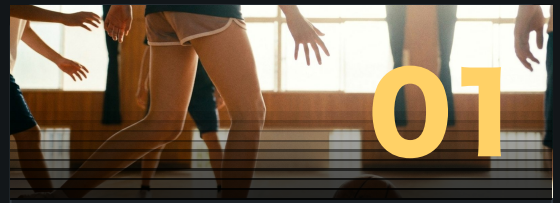
痛いって言うのは、弱いことじゃない。

体からの連絡。早く言った方が、

早くコートに戻れる。

なぜ？

理由は3つ



骨が先に伸びる

骨が先に伸び、筋肉や腱が追いつくまで時間差がある。

= 骨端線(成長軟骨)



引っ張られる所が痛む

膝の下・かかと・腰。腱がつく場所に、着地の負担が重なる。

= 骨端症



やりすぎると増える

週の練習が長いほど、痛みが出る確率は上がる。

= オーバーユース

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

骨端線（成長軟骨）

子どもの骨の端にある、骨が伸びる軟骨の層。大人の骨より弱い。

この講では

ここに繰り返し力がかかると、痛みが出やすい。

オスグッド病・シーバー病

膝のお皿の下が痛むのがオスグッド。かかとが痛むのがシーバー。

この講では

名前を知っておくだけで十分。判断は医師がする。

「成長痛」とは別物

医学でいう成長痛は、夜に痛んで朝に消え、腫れがないもの。

この講では

運動中の痛みに「成長痛だから」は当てはめられない。

もう一歩深く——バスケの原理

1 受診の目安

2週間以上続く。片脚だけ、いつも同じ場所。腫れや熱がある。朝も痛い。足を引きずる。つまり、どれか一つでも整形外科へ。この教材は診断をしない。

2 出場の判断を家だけで決めない

「痛いけど出たい」の気持ちは大事。でも、出るかどうかは医師の診察のあとで。つまり、長い目で見れば、それが競技人生を守る。

3 家でできる範囲

痛い動きを無理に続けない。お風呂と睡眠と食事で土台を整える。ストレッチで痛むなら、無理に伸ばさない。個人差がある。痛みは我慢しない。受診が先。

僕の話

僕は指導者で医師じゃないから、体のことは断定しない。

決めているのは一つだけ。痛みは我慢しない。受診が先。

そこで気合や我慢を求めるのは、技術の指導でも育成でもない。

アキレス腱を切った経験から、違和感の段階で止める価値を知っているんだよね。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 痛みが出やすいのは、
  膝のお皿の下・かかと
  の後ろ・腰。
- 階段や正座、
  片脚ジャンプで、
  顔をしかめていないか。
- どれか一つでも当ては
  まれば、整形外科へ。

NEXT GAME｜次の試合でやること

試合前のアップで「今日、気になるところある?」と一言聞く。

「ない」でも「ある」でもいい。聞かれること自体が「言っていい」のサインになる。

親の人へ

「痛い」「重い」を口にした時に、我慢させていないか。

言葉にしなくても、階段・正座・片脚ジャンプで顔をしかめていないか。気になれば受診が先。